

graves 病

甲亢的分类

1. 最常见的甲亢类型？哪种甲亢常伴突眼？哪类甲亢常伴心肌损害？

答：原发性甲亢。原发性甲亢。继发性甲亢。

临床表现

2. Graves 病的可能可能最可能？

答：多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体、有的时候不能走，甲状腺弥漫对称无痛肿大

3. Graves 病患者脉压如何变化？可导致何种类型心衰？

答：脉压显著增大：搏出量 $\uparrow$ →收缩压 $\uparrow\uparrow$ 、产热 $\uparrow$ →阻力血管舒张→外周阻力 $\downarrow$ →舒张压 $\downarrow\downarrow$ 。青年人多为高排量心衰、老年人多为低排量心衰，常有收缩期杂音。

4. Graves 病患者血糖、体脂、血胆固醇、以及蛋白质如何变化？

答：血糖 $\uparrow$ ，体脂 $\downarrow$ 、血胆固醇 $\downarrow$ ，蛋白质分解 $\uparrow$

5. Graves 病患者发生周期性瘫痪的原因是？常见于何种性别？典型症状是？可用何种药物预防？

答：血钾降低（主要是钾分布异常），亚洲男性青壮年易发生，双下肢对称肌无力。用乙酰唑胺预防

6. Graves 病患者甲状腺肿大的特点为？肿大程度与病情轻重是否完全相关？

答：呈弥漫对称性，甲状腺肿大程度与病情轻重不完全相关

7. Graves 病患者出现突眼一定是 Graves 眼病吗？

答：否。可为单纯性突眼（主要）：交感神经兴奋性增高

8. 患者眼球向下看时出现白色巩膜，应为何种征象？

A Joffroy 征

B Graefe 征

C Stellwag 征

D Mobius 征

答：B

9. 下列哪些是 GO 处于活动期的指标？

A. 视力下降 ≥ 1 行

B. 突眼度超过参考值 2cm

C. 眼睑充血、结膜充血、自发性球后疼痛

D. 任意方向眼球运动减少 ≥ 8 度

答：ACD。

10. GO 活动期可使用何种药物治疗？

答：可给糖皮质激素。GO：眶后组织自身免疫炎症反应（眶后成纤维细胞表面存在 TSH 受体，淋巴细胞 $\rightarrow$ TSAb 刺激 TSH 受体 $\rightarrow$ 透明质酸等黏多糖分泌 $\uparrow$ ）

11. 甲亢的黏液性水肿常见吗？常出现于何部位？水肿程度与什么有关？

答：少数患者。局限性（胫骨前最多见）。水肿程度与自身免疫反应程度有关。

甲亢的检查

12. 判断甲亢严重程度的指标？如何计算？如何进行严重分度？

答：基础代谢率 BMR。BMR=脉率+脉压-111。判断甲亢严重程度：轻度 20-30%、中度 30-60%、重度 60%以上

13. 甲亢术前准备对于 BMR 的要求？

答：BMR<20%

14. 诊断甲亢常用哪些指标？反映甲状腺功能最敏感的指标？

答：TSH↓、TT3↑、TT4↑、FT3↑、FT4↑。TSH

15. 哪个指标可以用来筛查甲亢？

答：TSH。反映甲状腺功能最敏感的指标，能用于筛查甲亢、诊断亚临床甲亢

16. T3 和 T4 哪个敏感性更高？

答：T3。T3 增高先于 T4

17. 诊断甲状腺高功能腺瘤应用何种检查？

答：核素

18. Graves 病甲亢的致病抗体、诊断指标、可用来判断预后、监测用药的是？

答：TRAb 中的刺激抗体 TSAb（TSH 受体刺激免疫球蛋白 TSI）

19. Graves 病的最佳停药指标是？

答：抗体转阴

B站/公众号：小凯的医学之路

甲亢的治疗

20. 抗甲状腺药 ATD 治疗甲亢的机制？

答：抑制甲状腺过氧化物酶 TPO→甲状腺激素合成↓

21. 应首选哪种抗甲状腺药？如患者处于妊娠早期应选择？

答：首选甲巯咪唑/他巴唑 MMI，但妊娠早期（1-3 月）首选丙硫氧嘧啶 PTU

22. 患者出现何种不良反应需要停药？

答：粒细胞减少最严重：中性粒细胞 $<1.5 \times 10^9/L$ （白细胞 $<3 \times 10^9/L$ ）→停药（不是换药）

23. 使用 ATD 治疗过程中，若患者出现甲状腺明显增大，应如何处理？

答：可给左甲状腺素 L-T4

24. 手术治疗的适应症和禁忌症？

答：适应症：恶变、高功能腺瘤、中重度原发性甲亢（BMR>30%）、结甲等继发性甲亢、胸骨后甲状腺肿、甲状腺显著肿大有压迫症状（我高中姐凶呀）

禁忌症：青少年、甲亢合并严重心肝肾功能不全

25. 放射碘治疗的禁忌症？

答：青少年、妊娠、哺乳、未来 6 个月内计划妊娠

26. 为避免放射性损伤后引起一过性高甲状腺激素血症加重心脏病变需同时给什么药物？

答：普萘洛尔

特殊类型甲亢

27. 甲亢患者出现甲状腺危象最主要原因？

答：术前准备不充分（最主要）、甲亢治疗不当、感染、精神因素等应激

28. 甲状腺危象的临床表现？

答：高热大汗、上吐下泻、谵妄昏迷

29. 甲危的治疗首选？还可用哪些药物？患者高热时应如何降温？

答

PTU（首选）	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$ 、抑制 TH 合成
大剂量碘	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$ 、抑制 TH 释放（也能抑制 TH 合成）
普萘洛尔	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$ 、拮抗交感神经
氢化可的松	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$ 、增强应激能力提高机体耐受
物理降温	禁用水杨酸类 （阿司匹林抑制血浆蛋白与 TH 结合致游离 TH 增多、阿司匹林致大量出汗加重脱水）

30. 老年人常见的特殊类型甲亢有哪些？

答：T3 型甲状腺毒症、亚临床甲亢、淡漠型甲亢

31. 亚临床甲亢什么指标会异常？

答：老年人多见，仅有轻微的甲亢表现；T3、T4 正常，TSH ↓

32. 淡漠型甲亢的主要表现为？

答：乏力淡漠、明显消瘦、常伴房颤、易发甲危

33. 诊断妊娠期甲亢应用什么指标？

答：妊娠 → 甲状腺结合球蛋白 TBG ↑ → TT3、TT4 ↑（总 TT4 = 游离 FT4 + 与 TBG 结合的 T4），
所以妊娠期诊断甲亢不用 TT3、TT4

34. （***）下列哪些情况可以使 TBG 升高？

- A. 妊娠
- B. 雄激素
- C. 雌激素
- D. 糖皮质激素
- E. 肾病综合征

答：AC。TBG ↑：妊娠、雌激素（某些避孕药）、急性病毒性肝炎等

TBG ↓：雄激素、糖皮质激素、低蛋白血症（如肾病综合征）

甲状腺功能减退

1. 甲减最常见的类型是？

答：原发性甲减

2. 下列哪些可以作为甲减的病因？

- A. 桥本甲状腺炎
- B. 胺碘酮
- C. 甲状腺手术
- D. 希恩综合征
- E. Graves 病

答：ABCD。

3. 诊断甲减可用哪些指标？T3 一定会下降吗？

答：TSH ↑、T4 ↓，T3 正常或 ↓（T3 不作为诊断甲减的必备指标）

4. 甲减严重程度与什么有关？

答：甲状腺激素含量

5. 甲减的可能可能最可能？

答：便秘、怕冷、体重可增加、表情淡漠、跟腱反射减弱

6. 甲减的水肿类型？若合并什么其水肿可能不典型？

答：黏液性水肿/非凹陷性水肿（组织间隙黏蛋白沉积），心包积液出现后非凹陷性水肿有时候可能不典型。

7. 鉴别原发与继发甲减的指标？其分别的变化是？

答：TSH。原发性：TSH 增多，继发性：TSH 减少

8. 诊断低 T3 综合征的关键？

答：逆/反 rT3 ↑（关键）、T3 ↓，T4 和 TSH 正常。

9. 甲减应如何治疗？

答：终身左甲状腺素替代治疗

10. 若要调整 L-T4 剂量，应多久检查什么指标？中枢性甲减应查什么？

答：每 4-6 周测定 TSH 以调整 L-T4 剂量（但中枢性甲减要依据 FT4 而非 TSH 调整剂量）。

11. 抢救黏液性水肿昏迷首选？

答：碘塞罗宁 L-T3

原发性醛固酮增多症（高血压+低血钾在病例题先考虑原醛）

临床表现

1. 原发性醛固酮增多症最早、最常见的临床表现是？

答：高血压

2. 原醛患者可出现下列哪些表现？

- A. 肌无力、周期性瘫痪
- B. 代谢性碱中毒
- C. 糖耐量下降
- D. T波高耸
- E. 高U波

答：ABCE。

3. 下列哪些情况可以导致糖耐量下降？

- A. 糖尿病
- B. 高钾
- C. 肥胖
- D. 应激
- E. 尿毒症
- F. 肾性糖尿

答：ACDE。

小结糖耐量↓（影响胰岛素）：胖机甲a尿尿

糖尿病	胰岛素绝对或相对缺乏
应激	体内拮抗胰岛素的激素增多 糖皮质激素(较弱的醛固酮作用)→严重库欣综合征才会低钾
低钾	如原醛、严重库欣综合征、嗜铬细胞瘤、甲亢
肥胖	胰岛素抵抗
尿毒症	小分子毒素 中分子毒素:PTH 大分子毒素:蛋白质
应用水杨酸类药	如阿司匹林

（干扰选项：肾性糖尿——近端小管重吸收葡萄糖障碍）没有糖耐量↓

4. 原醛患者血钠、尿钾、尿液呈酸性还是碱性？

答：高血钠、高尿钾、尿不呈酸性。

5. 原醛患者醛固酮增多可以保水，患者是否会出现口渴？

答：会。多尿、夜尿、正常或低比重尿（ <1.012 ），口渴（虽然醛固酮在保水、但机体也在失水）

检查

6. 下列哪些是原醛的特征，可以帮助诊断？

- A. 血醛固酮增加
- B. 肾素减少
- C. AngII 增加
- D. 血醛固酮/肾素 >20

B站/公众号：小凯的医学之路

答：AB。特征：血醛固酮↑、肾素↓、Ang II ↓，血醛固酮/肾素>30

治疗

7. 对于特发性醛固酮增多症，应首选什么治疗？

答：螺内酯

8. 醛固酮瘤如何根治？术前应用什么药物？

答：手术根治，术前用螺内酯

9. 原醛患者可使用下列哪些药物治疗？

- A. 阿米洛利
- B. 氨氯地平
- C. 卡托普利
- D. 醛固酮

答：ABC。

B站/公众号：小凯的医学之路

嗜铬细胞瘤（血压乱七八糟）

概述

1. 嗜铬细胞瘤被称为 90% 肿瘤，主要体现在？

A. 90% 为良性肿瘤

B. 90% 发生在肾上腺髓质

C. 90% 呈散发性

D. 90% 为单发

答：ABC

2. 嗜铬细胞瘤主要分泌激素为？次常见发生部位？

答：主要分泌去甲肾上腺素，次常见为腹主动脉旁

临床表现

3. 嗜铬细胞瘤患者血压可呈什么特点？

答：血压不稳定：持续性、间歇性/阵发性高血压、低血压、休克

4. 嗜铬细胞瘤患者的常见临床表现有哪些？

答：心悸、多汗、头痛、便秘（儿茶酚胺抑制消化系统）、面部苍白、肠扩张和坏死出血、胆汁潴留和胆结石

其他激素

5. 患者腹泻与下列哪些有关？

A. 血清素

B. 舒血管肠肽

C. 胃动素

D. 血管活性肠肽

答：ACD

6. 若患者出现血管舒张、面部潮红、低血压，与下列哪些有关？

A. P 物质

B. 生长抑素

C. 神经肽 Y

D. 肾上腺髓质素

E. 肾上腺素

答：AD。

生长抑素、阿/鸦片肽	便秘
血清素、胃动素、血管活性肠肽	腹泻（腹泻清胃肠）
神经肽 Y	血管收缩、面部苍白（Y-white）
P 物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素	血管舒张、面部潮红、低血压（放屁舒服随后脸红）

垂液分泌递质共存：交感神经又有去甲肾上腺素（分泌唾液、收缩血管）又有神经肽 Y（收缩血管）

III 嗜铬细胞瘤低血压和休克机制

检查

7. 嗜铬细胞瘤发作期可检查什么指标？

答：血、尿儿茶酚胺及其代谢物

8. 如何对肿瘤进行定位？

答：影像学

治疗

9. 常用的治疗方法为？

答：手术治疗

10. 术前应常规使用何种药物？

答：常规用 α -R 拮抗剂（酚苄明、哌唑嗪、多沙唑嗪）。 α -R 拮抗剂不少于 2 周、用到术前一天为止。

11. β -R 拮抗剂在嗜铬细胞瘤的“三不”？

答：①不常规用：出现心动过速、心律失常再加用 β -R 拮抗剂

②不单独用

③不会先用：否则可使血压升高、急性左心衰（肺水肿）

12. 术中若接触肿瘤等出现急骤血压升高，应选择什么药物将血压控制在什么水平？哪种药物为首选？

答：酚妥拉明（首选）或硝普钠控制在 160/100。

站/公众号：小凯的医学之路

库欣综合征（激素怎么补看肾上腺怎么切）

临床表现

1. 库欣综合征最早的临床表现？

答：高血压

2. 库欣综合征患者可出现下列哪些表现？

- A. 向心性肥胖
- B. 骨质疏松
- C. 贫血
- D. 皮肤紫纹

答：ABD

3. 低钾碱中毒可见于库欣综合征的哪些类型？

答：重型库欣病、异位 ACTH 综合征、肾上腺皮质癌

病因

4. 库欣综合征最常见的病因是？

答：库欣病

5. 异位 ACTH 综合征常见哪些疾病？

答：小细胞肺癌和类癌、胸腺癌等

6. 双侧肾上腺大结节性增生 如食物依赖性库欣综合征，餐后和清晨空腹时皮质醇分别如何变化？

答：抑胃肽受体在肾上腺皮质异位表达→餐后皮质醇分泌增多、而清晨空腹时皮质醇正常或降低

检查

7. 要确诊库欣综合征应选择什么检查？要确定病因应选择什么检查？

答：小剂量地塞米松抑制试验，大剂量地塞米松抑制试验

8. ACTH 兴奋试验阳性可见于哪些库欣综合征？

答：库欣病，异位 ACTH 综合征

9. 女，42 岁。向心性肥胖伴乏力 2 年。查体：BP 180/110mmHg，满月脸、多血质，皮肤可见宽大紫纹，血糖 12.6mmol/L，血钾 3.7mmol/L，尿皮质醇增高，小剂量地塞米松试验不能抑制，大剂量地塞米松试验能抑制。为明确病因，除肾上腺 CT 检查外，最需要进行的检查是

- A. 头颅 CT
- B. 鞍区 MRI
- C. 胸部 CT
- D. 肾区 B 超

B站/公众号：小凯的医学之路

E.肾动脉造影

答：B

10.男性，32岁。肥胖伴血压增高3个月。查体：BP 150/90mmHg，面如满月，四肢相对瘦小，腹部及大腿内侧皮肤可见紫色条纹。化验血皮质醇增高，血糖增高。颅脑MRI提示垂体微腺瘤。下列符合该疾病的检查结果是

A.血皮质醇昼夜节律消失

B.大剂量地塞米松抑制试验(+)

C.ACTH 兴奋试验(+)

D.B 超示双侧肾上腺皮质弥漫增生

答：ABCD

治疗

11.库欣病的首选治疗？应如何补充激素？

答：首选经蝶窦切除肿瘤+短期补激素

12.若患者手术及放疗均失败，应如何治疗，如何补充激素？

答：切除双侧肾上腺+终身补激素

13.单侧肾上腺皮质瘤/癌应如何治疗？如何补充激素？

答：切除患侧肾上腺+较长期补激素（半年-1年或更久）

14.不依赖 ACTH 的双侧肾上腺小/大结节性增生应如何治疗，如何补充激素？

答：切除双侧肾上腺+终身补激素

B站/公众号：小凯的医学之路